

anexo ou
conferido ou

INDICADO POR: Drº Zampa	
X ACOMPANHAMENTO X CONSULTA	
NS	
Rosely Hilda Teixeira Santos	
IDADE: 71	PESO: 65 ALTURA: 159
PROFISSÃO: Professora - Apos.	
SINTOMAS: Cansaço indisposta / mmII (+ perna d)	
QUEIXAS: Parada resp. da família	
MEDICAMENTOS: Diavam / Monocordil / Lipitor / Ezetecol / Zyloric / AAS / Hipotireoide / Aldactone / Sintroid / Zolozer / Larix	
MÉDICO: Drº Genivaldo / Drº Zampa	
MARCAPASSO: X () N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S () N Há 1 ano.	
EXERCÍCIO FÍSICO: Caminha (5x semana)	
HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S	ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S (20:30)
HORA QUE DORME: 23	HORA QUE ACORDA: 5:30
COCHILHO () S X N	DORME ACOMPANHADO: X S () N () EVENTUALMENTE
TEM FILHOS: X S () N / DORMEM NO QUARTO: () S X N	PET NO QUARTO: () S X N
BEBIDA ALCOÓLICA: X S () X NA SEMANA () N - às vezes	
FUMO: () S () MAÇO/DIA X NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista	BANHEIRO/NOITE: 2x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:	CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP:	MALLAMPATI: IAH: 74.5 SPO2: 80%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Cirurgia pl colocação de stent na aorta e marcapasso.	
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA	Microdisp. 28.9 efer
HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA	
() ORTOPÉDICA	(S) NEUROLÓGICA () OUTROS: esquecido
POLISSONOGRAMA COM CPAP: X S () N	SPO2 C/ CPAP: 87% PRESSÃO NO EXAME: 6
08/07 Avaliação	
25 Dorme bem. ↓ edema, s/ alterações de adapt.	
15/07 P=6 / IAH=2.2 / m. de uso: 3m. fua.	
22/07 P=6 cm H2O	
25 IAH=1.5 e 1lv	
m. de uso: 7h30	
Fuga=3.4 lpm.	
(ajuste máscara / melhora conforto / melhora dia seguinte) e no x banheiro fua claudia	
02/09 Não acorda mais cansada e nem p/ ir p/ o	
25 banheiro	
P=6 cm H2O	
IAH=0.8 efer	
m. de uso: 7h40'	
fuga=	
fua	

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Rosely Hilda Teixeira Santos
EXAME nº: 5600
SOLICITADO POR: Dr. Antonio Carlos Zampa
DATA: 19/04/2024
IDADE: 70 anos

Comentários:

Exame iniciado às 23h03min e concluído às 06h05min. A latência para o sono foi de 7 minutos e a latência para o estágio REM, de 263 minutos. O tempo total de sono foi de 378,5 minutos (06h18min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,6%. A distribuição do sono mostrou 21,4% de estágio 1, 59,6% de estágio 2, 5,4% de estágio 3 e 13,6% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 32 minutos em vigília, ocorreram 182 microdespertares (índice: 28,9/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 74,5/hora, sendo 37,1 apneia/hora e 37,4 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 74,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 93%, sendo a média de 90% e a mínima de 80%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (74,5/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (74,5/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, despertares e episódios de arritmia cardíaca. As frequências cardíacas foram: mínima: 58; máxima: 75 bpm.

O ronco foi contínuo e variou de baixo a médio.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu rapidamente (latência para o sono: 7 min; normal até 30 min). A latência para o sono REM estava alongada (263 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono (90,6%; normal: 85% ou acima) permanecer no limite da normalidade, o sono foi fragmentado microdespertares (índice: 28,9/hora; normal até 15/hora) – observei o padrão alternante cíclico (PAC) no estágio 2. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (21,4%; normal: 8-10%) e 2 (59,6%; normal: 45-55%), e a redução dos estágios 3 (5,4%; normal: 10-12%) e REM (13,6%; normal: 20%).

Sem movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 4 (normal até 9; máxima: 24).

30c Av. SAOS ~~A~~

2 Exams & Paper
analysis

era - Caraguatatuba - SP. (12)

09-06-2025